Examen clinique du patient et fiche d'observation

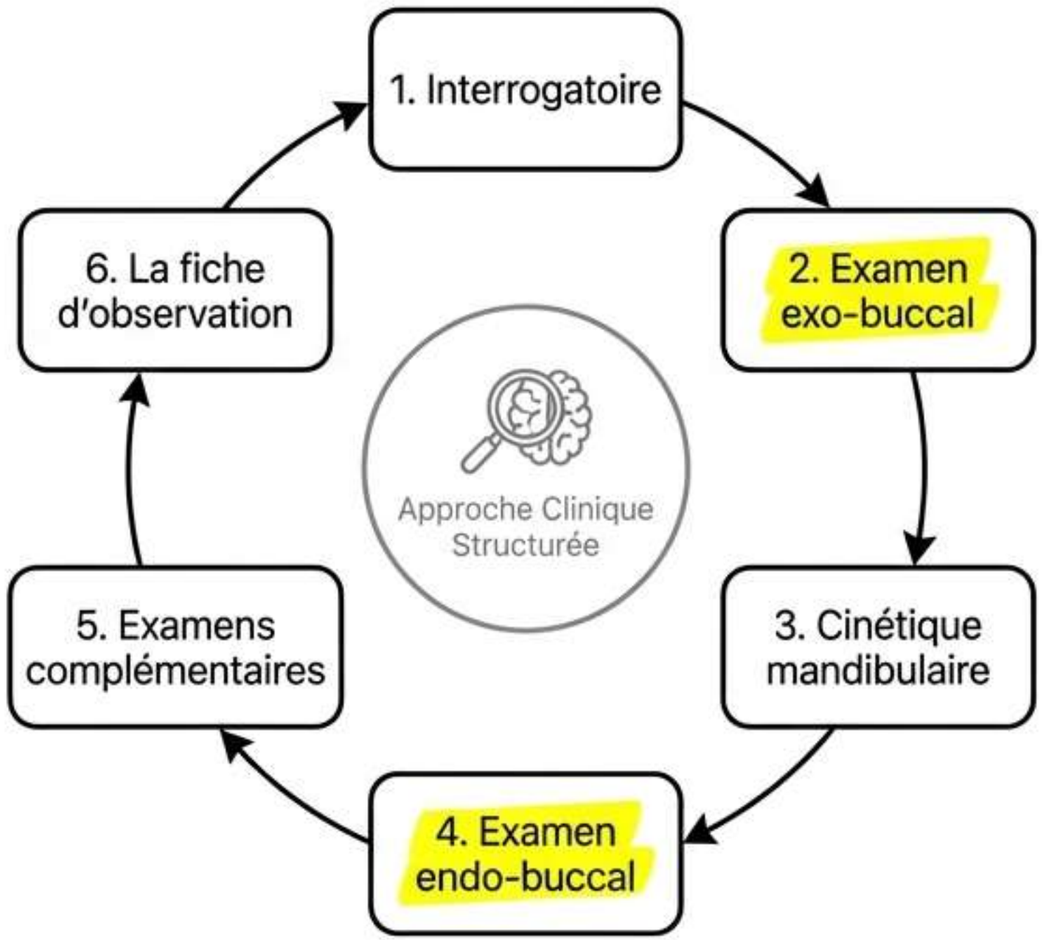
L'étape initiale essentielle dans l'approche diagnostique de toute pathologie médicale.

Dr. SAIDI.K

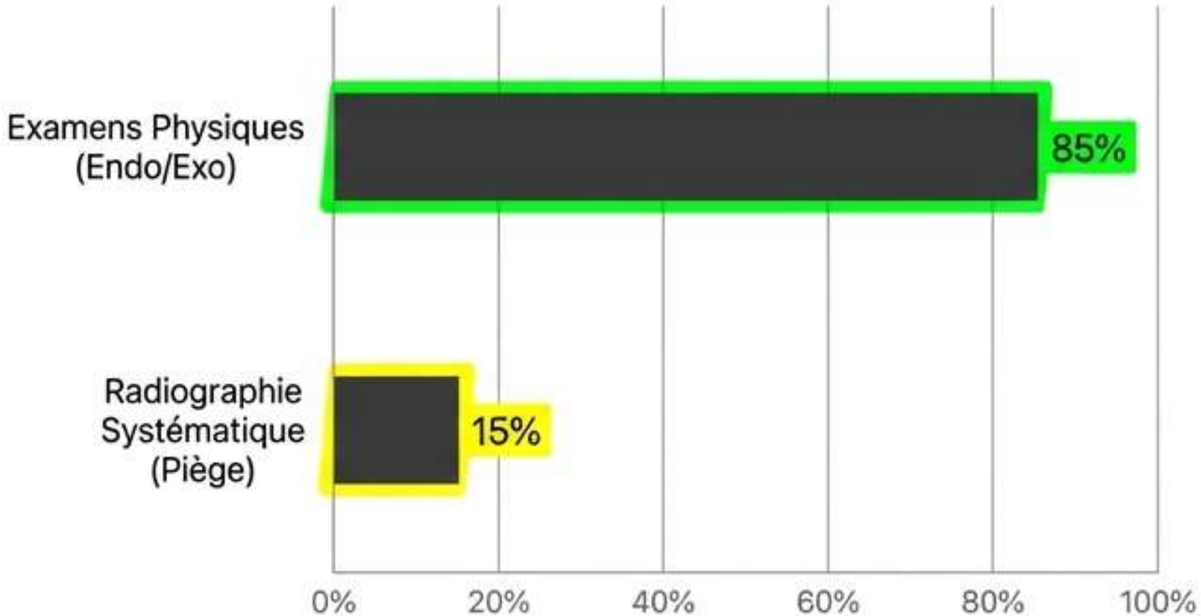
Année Universitaire 2024-2025

Dentist Web

Le Plan : La Trajectoire Diagnostique



Fréquence des Thèmes aux Examens



Analyse Stratégique des Examens

- **Thème le plus répété** : Caractère incontournable des examens physiques vs non-systématique des complémentaires.
- **Piège Identifié** : La radiographie est souvent présentée comme étape préliminaire obligatoire (c'est TOUJOURS un distracteur).
- **Confiance de Prédiction** : 95% sur les définitions cliniques, 85% sur les seuils millimétriques précis.

Dentist Web

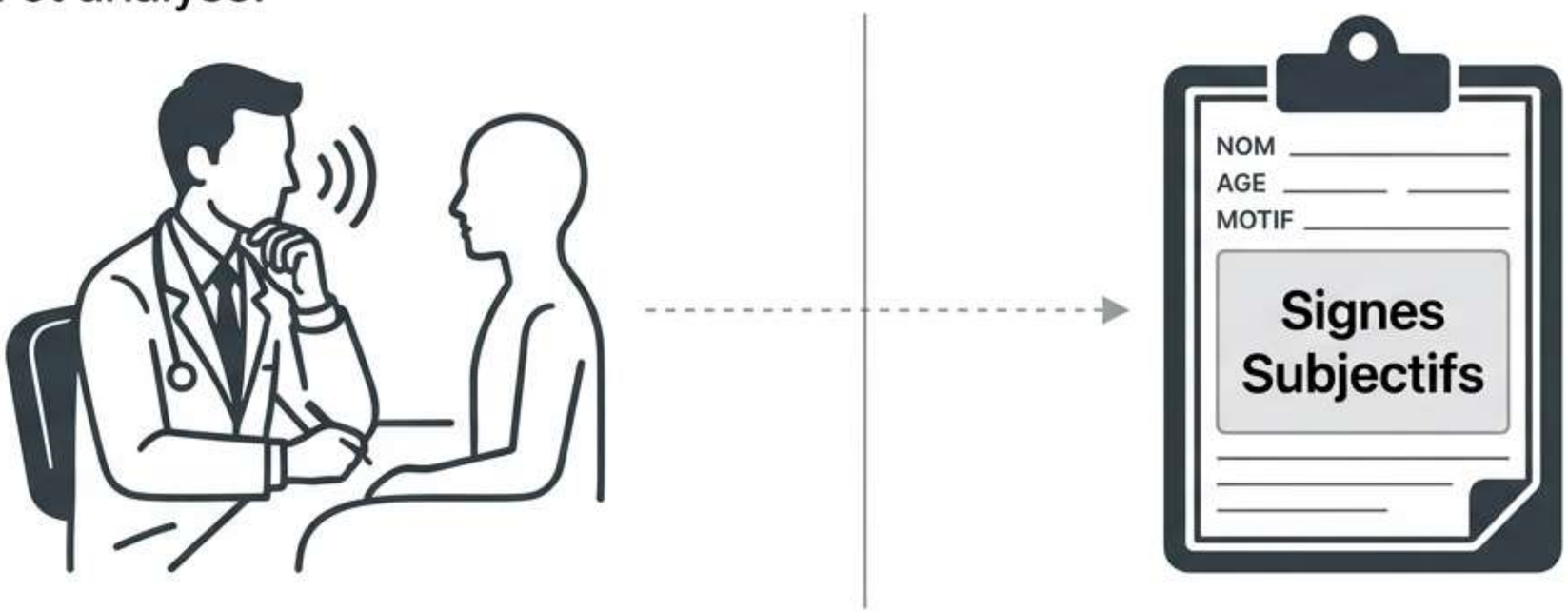
L'Interrogatoire : Le Premier Contact

Définition : Le premier temps de l'examen et le premier contact avec le patient. Étape décisive qui conditionne les rapports de confiance ultérieurs.

Permet de recueillir les signes subjectifs et de déterminer le diagnostic dès le départ. [Ref: Q20]

Données initiales :

- **État civil** : nom, âge, profession.
- **Le motif de la consultation** : L'éventail des symptômes conduisant à la consultation est recueilli et analysé.



Dentist Web

L’Interrogatoire : Les 4 Piliers Médicaux

1. État Général

Pathologies et traitement médicamenteux en cours.
Objectif : évaluer si l'état général peut affecter le pronostic de traitement.

Haut risque d'endocardite infectieuse, immunodépression, risque hémorragique (prise d'AVK, hémophilie), risque allergique ou toxique (interactions médicamenteuses). [Predicted - High probability matching questions pour risques systémiques]

2. Antécédents

Ayant une incidence sur les traitements envisagés ou imposants certaines précautions.

3. Historique

Episodes douloureux, difficultés d'extraction

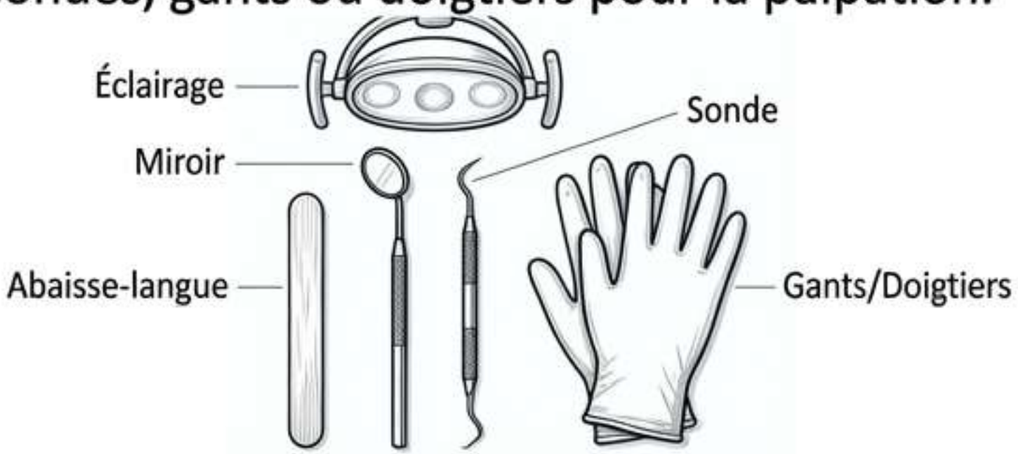
4. Habitudes

Hygiène bucco-dentaire, tabac, alcool.

Dentist Web

Examen Proprement Dit : Principes Généraux

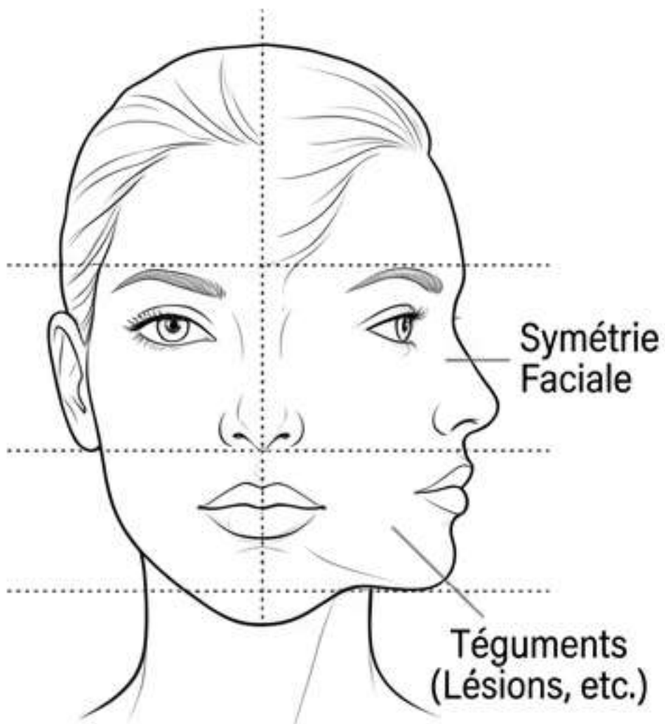
- **Principes** : Orienté par les résultats de l'interrogatoire. Vise à dépister les signes objectifs de l'affection.
- **Méthode** : À la fois visuel (inspection) et palpatoire. Réalisé par comparaison à la normalité et symétriquement.
- **Séquence** : Commence classiquement par l'examen exo-buccal (ou cervico-facial) et se poursuit par l'examen endo-buccal (le cas échéant, examen somatique général).
- **Installation & Équipement** : Patient installé confortablement sur un fauteuil. Éclairage de bonne qualité, abaisse-langue, miroirs, sondes, gants ou doigtiers pour la palpation.



Dentist Web

Examen Exo-Buccal : Inspection et Palpation

L'examen clinique exo-buccal est une étape incontournable de la consultation initiale. [Ref: Q1, Q4]

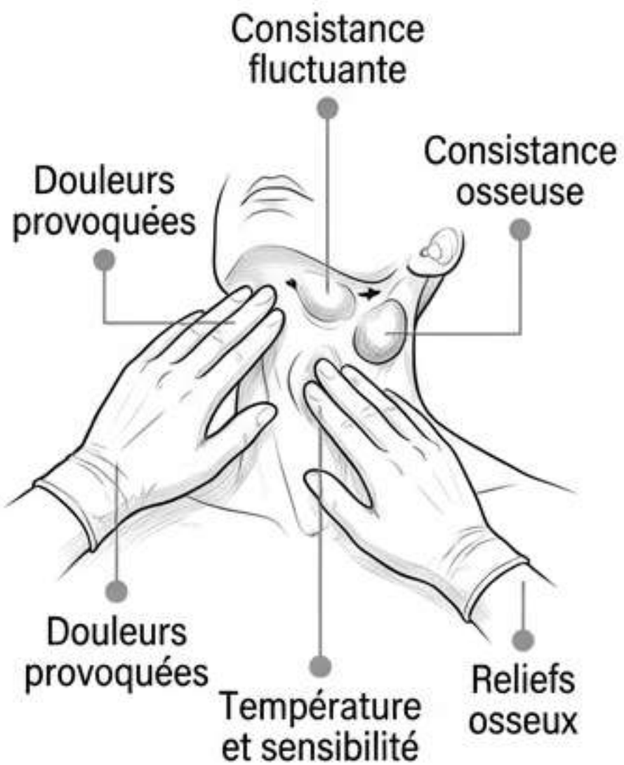


L'inspection (3 Incidences) : Face, profil, incidence axiale.

- Rapports des 03 étages de la face et symétrie faciale : Asymétrie parfois consécutive à un processus infectieux, inflammatoire ou adénopathies.
- Aspects des téguments : Coloration, souplesse, lésions cutanées (plaies, éruptions, cicatrices).

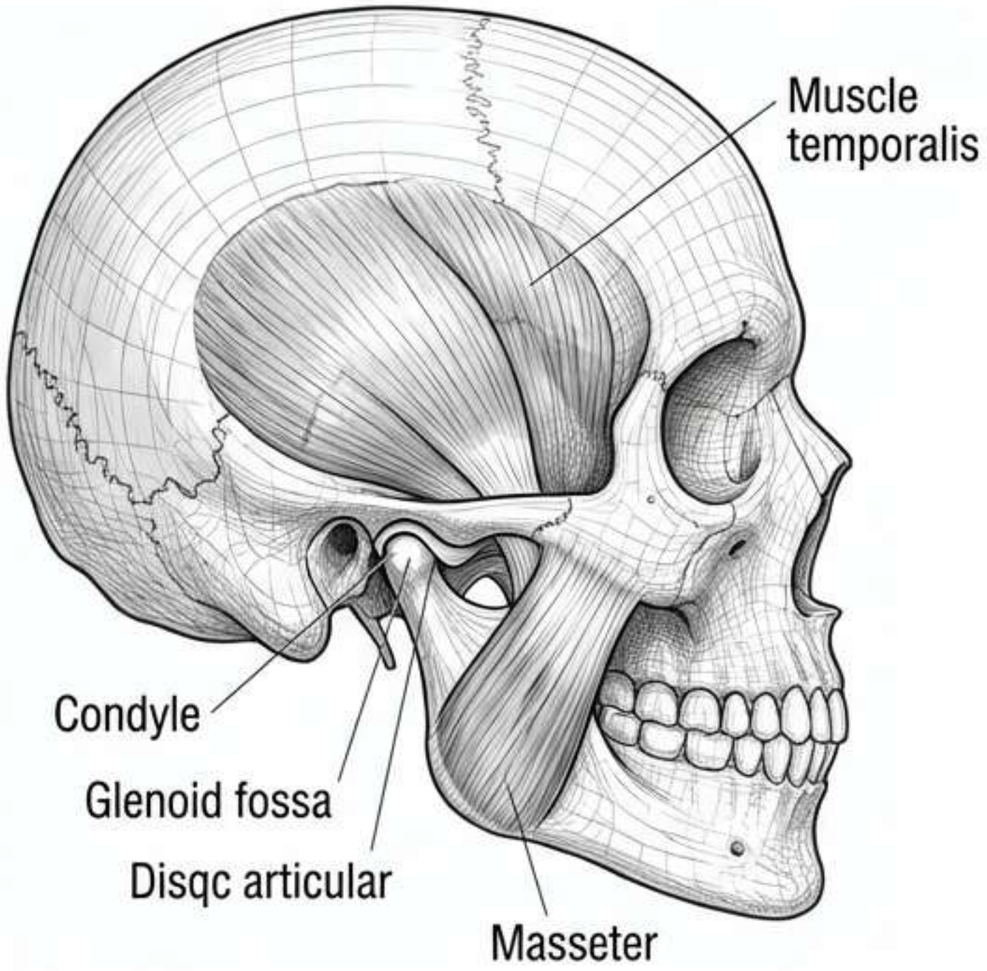
Règles de Palpation : Douce et progressive, un ou plusieurs doigts, une ou deux mains. Apprécie :

- Douleurs provoquées (diffuses ou exquises).
- Téguments (température et sensibilité).
- Tuméfaction (consistance osseuse vs fluctuante, mobilité par rapport aux plans sous-jacents).
- Reliefs osseux (contexte traumatologique : décalage, mobilité anormale).



Dentist Web

Examen Exo-Buccal : A.T.M, Muscles et Nerfs



- **L'A.T.M (Articulations temporo-mandibulaires) :** Palpation bimanuelle, comparative.
  Permet de percevoir les mouvements condyliens (symétrie et coordination ou asynchronisme). [Ref : Q4]

  Le côté le plus sensible/douloureux et l'existence de bruits articulaires (claquements ou craquements) font évoquer un syndrome dysfonctionnel de l'appareil manducateur (SADAM).
  [Predicted - Clinical scenario question]

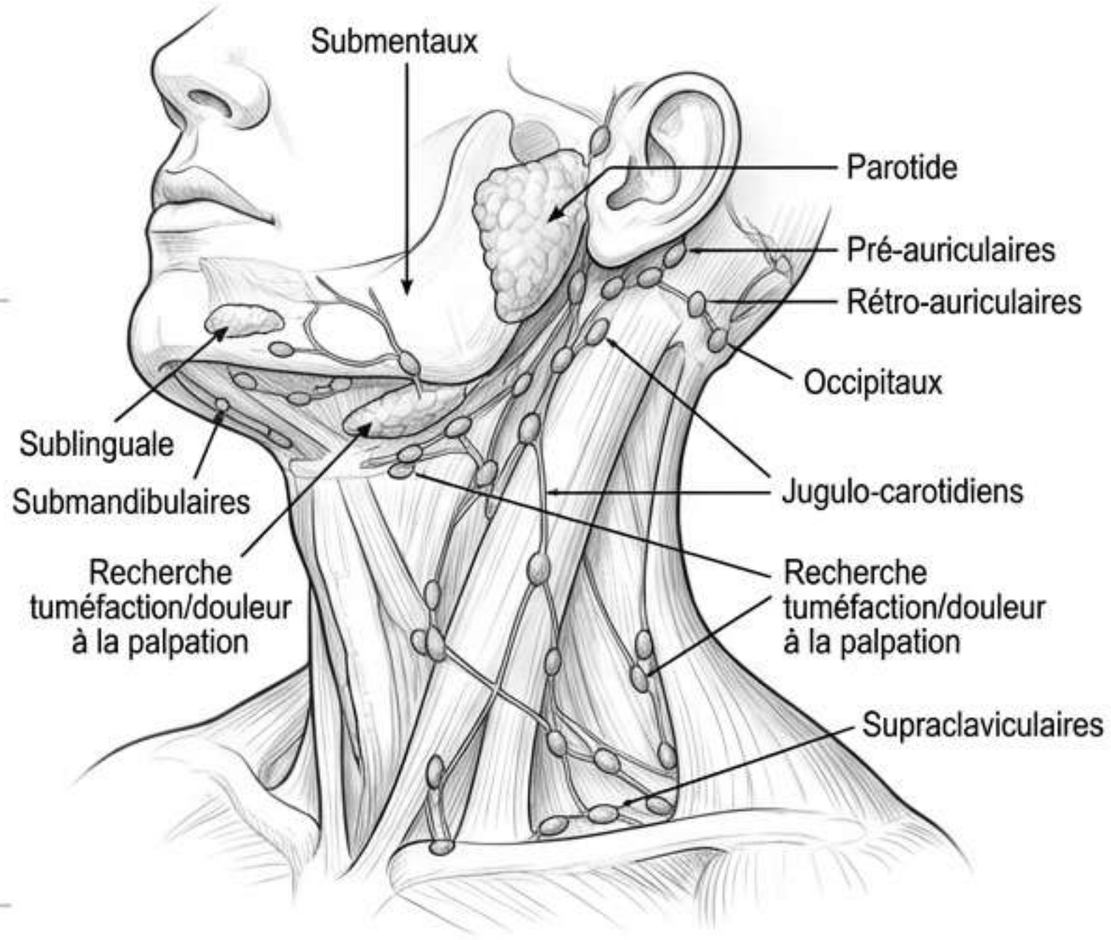
- **Muscles masticateurs :**
  Recherche de zones douloureuses au niveau des insertions.

Nerf Trijumeau (V)	Nerf Facial (VII)
Sensibilité (Hypo/Hyperesthésie)	Motricité (Déficit moteur)

Dentist Web

Examen Exo-Buccal : Aires Ganglionnaires et Glandes

L'examen des aires ganglionnaires est systématique quel que soit le motif de consultation et se fait lors de l'examen exo-buccal. [Ref: Q4, Q8]



Aires Ganglionnaires : Temps essentiel s'orientant vers un contexte néoplasique, infectieux ou hématologique.

Les 6 critères à préciser obligatoirement :

- ☐ 1. Nombre (unique ou polyadénopathie)
- ☐ 2. Localisation
- ☐ 3. Taille
- ☐ 4. Consistance
- ☐ 5. Mobilité (plans superficiels/profonds)
- ☐ 6. Sensibilité

Dentist Web

Examen de la Cinétique Mandibulaire

L'examen de **la cinétique mandibulaire** met en évidence le **jeu des condyles mandibulaires. [Ref: Q4, Q5 (2024)]**

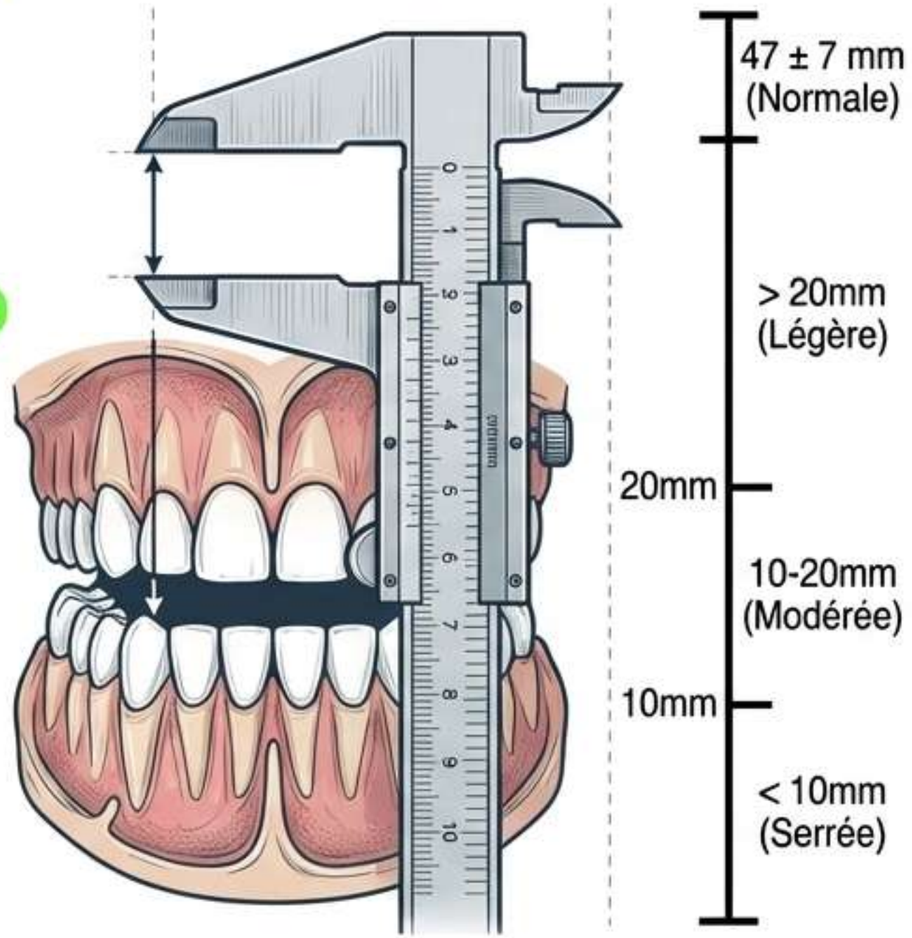
Ouverture Buccale : Mesurée à l'aide des doigts ou d'un pied à coulisse (espace entre points inter-incisifs inférieur et supérieur).

Valeur de référence d'une ouverture normale : 47 ± 7 mm (3 travers de doigt). [Predicted - High risk for multiple choice numbers]

Classification des limitations :

- > 20 mm : Légère
- 10 à 20 mm : Modérée
- < 10 mm : Serrée

Le trajet d'ouverture/fermeture : Régularité dans le plan sagittal (ouverture rectiligne ou déviée).

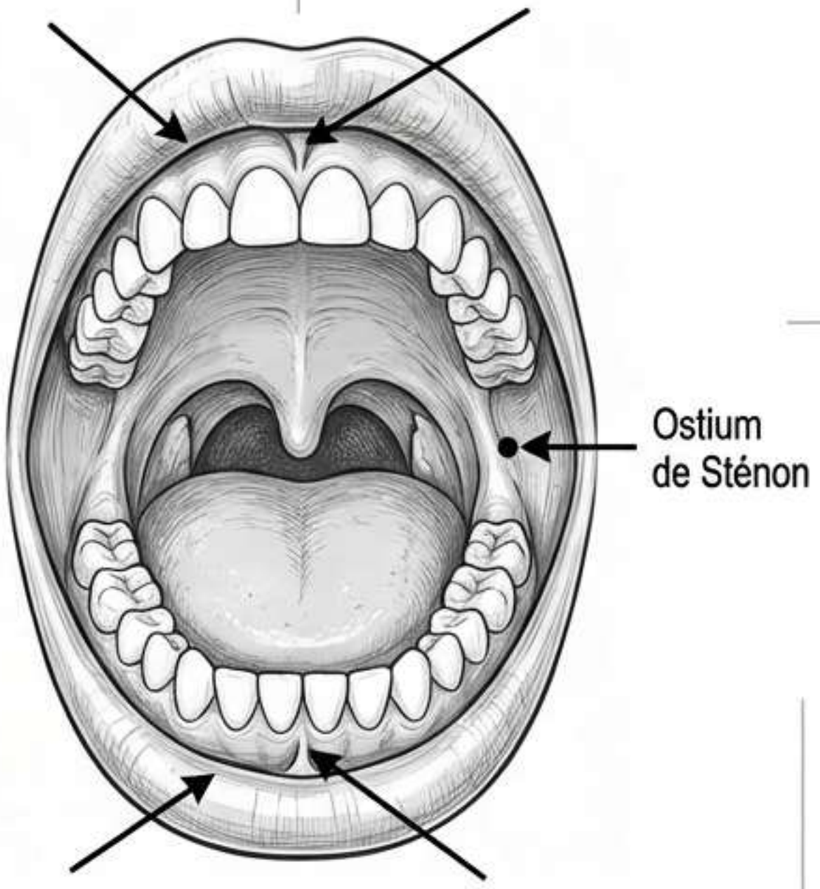


Dentist Web

Examen Endo-Buccal : Muqueuses, Hygiène, Lèvres et Joues

L'examen clinique endo-buccal est une étape incontournable de la consultation initiale. [Ref: Q5, Q9]

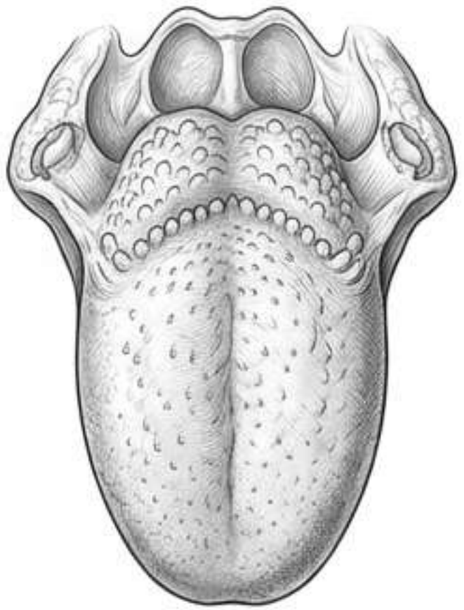
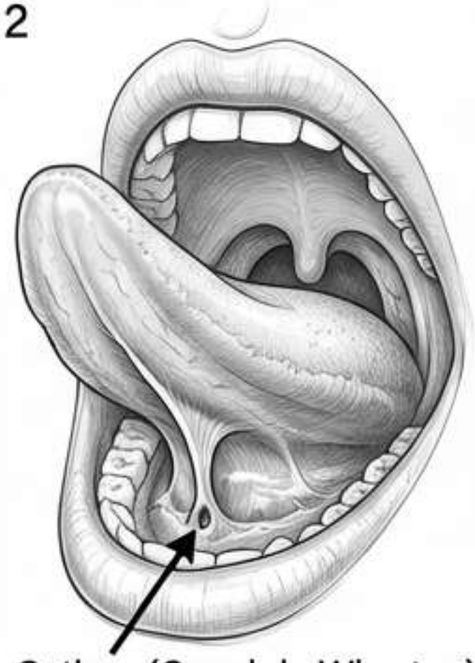
- **Principes** : Systématique, intéresse toutes les régions avec déplissement des plis muqueux. Examen avec ET sans prothèses.
- **Muqueuses** : Lésions élémentaires (érythèmes, érosions, ulcérations). Analyser topographie, aspect (couleur, souplesse).
- **Hygiène bucco-dentaire** : Contrôlée.
- **Lèvres** : Versant cutané/muqueux, tonus musculaire labial, hauteur d'insertion des freins (répercussion sur arcades/parodonte).
- **Joues (Face interne)** : État de la muqueuse. Ostium de Sténon (en regard de la 1ère molaire maxillaire). Pression sur parotide apprécie qualité/quantité de salive.



Dentist Web

Examen Endo-Buccal : Plancher Buccal et Langue

- Examen du plancher buccal :
  - Pointe de langue au palais.
  - Palpation bidigitale des glandes sous-maxillaires et sublinguales.
  - Qualité/quantité de salive à l'ostium (canal de Wharton).
- Examen de la langue (tractée avec deux doigts après compresse) :
  - **Statique (au repos) :**
    Forme (allongée/étroite),
    Volume (macroglossie vraie/relative, microglossie),
    Position.
    Aspect muqueuse (faces dorsale/ventrale, bords) : couleur, sensibilité, hyperplasie des papilles ou langue dépapillée.
  - **Dynamique (en fonction) :**
    Déglutition, phonation, mobilité.
    Rôle du frein : sa brièveté peut entraîner une ankyloglossie (impossibilité d'élévation ou protraction).
    Vision indirecte (miroir) pour la base.

Statique	Dynamique
1 	2  Ostium (Canal de Wharton)

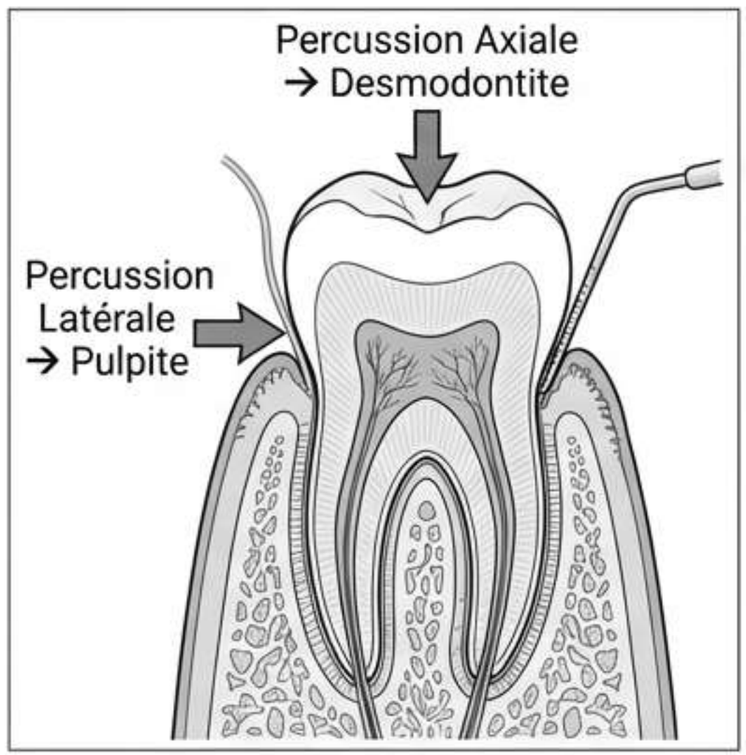
Dentist Web

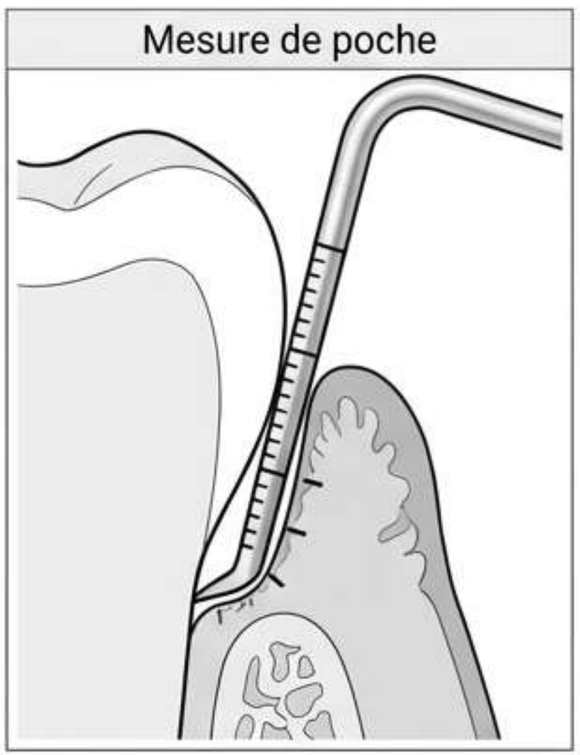
Examen Endo-Buccal : Voûte, Dents et Parodonte

- **Voûte palatine et voile du palais** : Examen direct/indirect. Abaisse-langue si langue chargée.
- **Dents** : Formule dentaire (manquantes, couronnées, cariées, malpositions).

Différentiel de Percussion : Percussion Latérale douloureuse = diagnostic probable de **Pulpite**. Percussion Axiale douloureuse = diagnostic probable de **Desmodontite**. **[Predicted - Classic differential diagnosis trap]**

- **Test de vitalité pulpaire** : Thermique/électrique ou coloration suspecte.
- **Parodonte** : Aspect (rose pâle), consistance (ferme), volume (gingivite hypertrophique), attaches (récessions au-delà jonction amélo-cémentaire), poches (sondes graduées), mobilité.





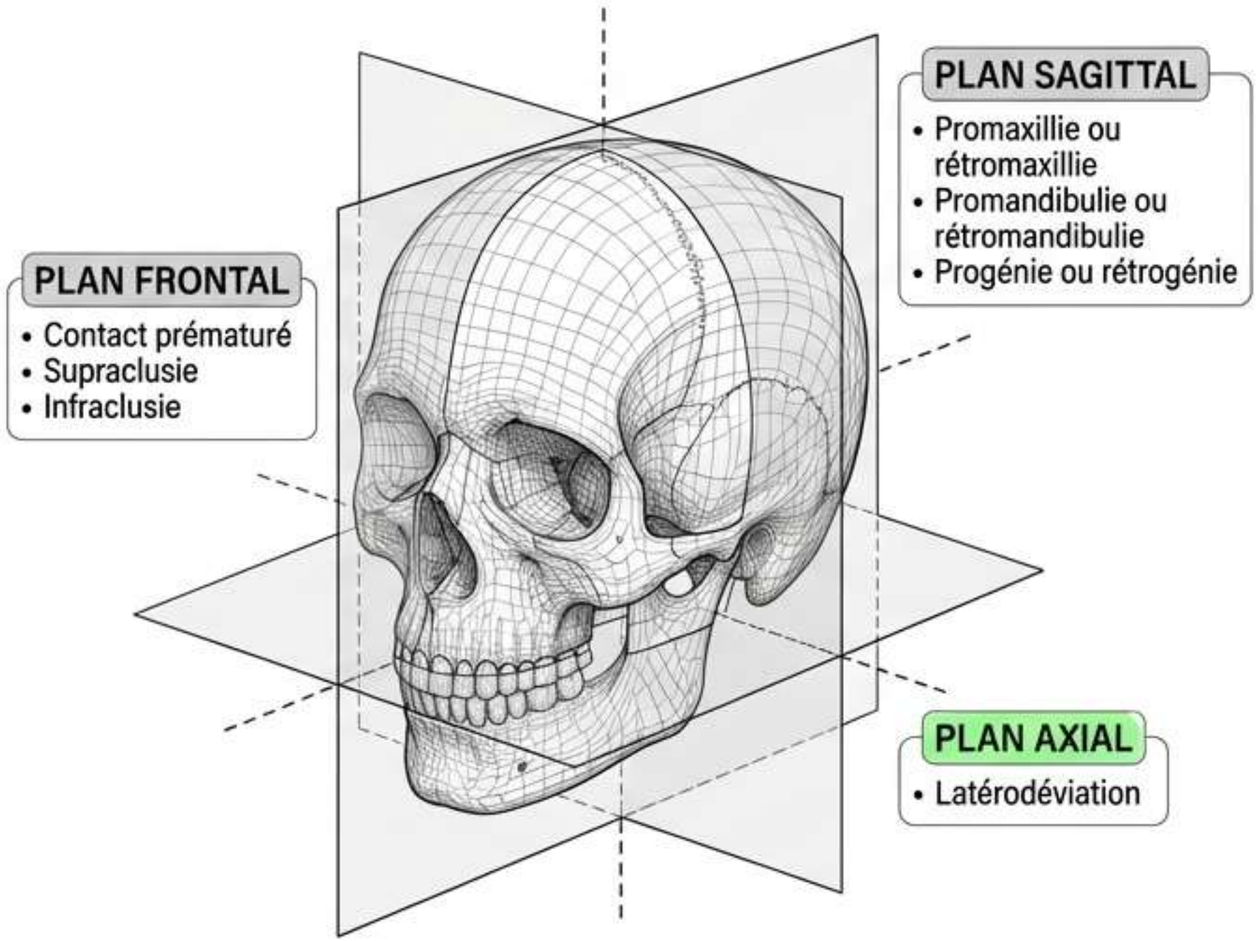
Dentist Web

Examen Endo-Buccal : L'Occlusion

Appréciation de l'articulé dentaire, point clé en pathologie malformative ou traumatologique.

Classification selon les 3 plans de l'espace :

- **Plan Frontal :** Contact prématuré, supraclusie, infraclusie.
- **Plan Sagittal :** Promaxillie ou rétromaxillie, promandibulie ou rétromandibulie, progénie ou rétrogénie.
- **Plan Axial :** Latérodéviation.



Dentist Web

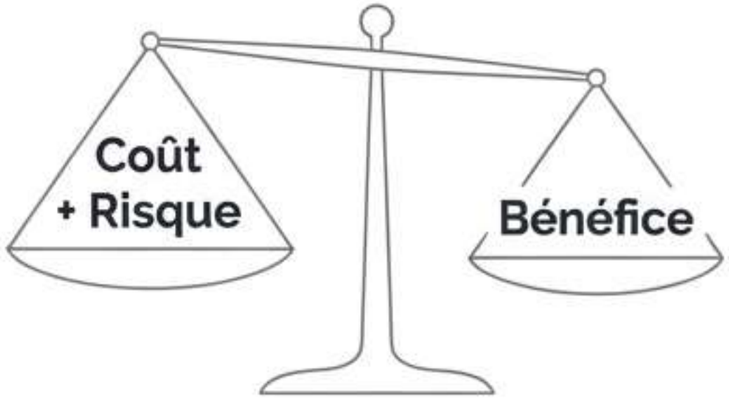
Examens Complémentaires et Fiche d'Observation

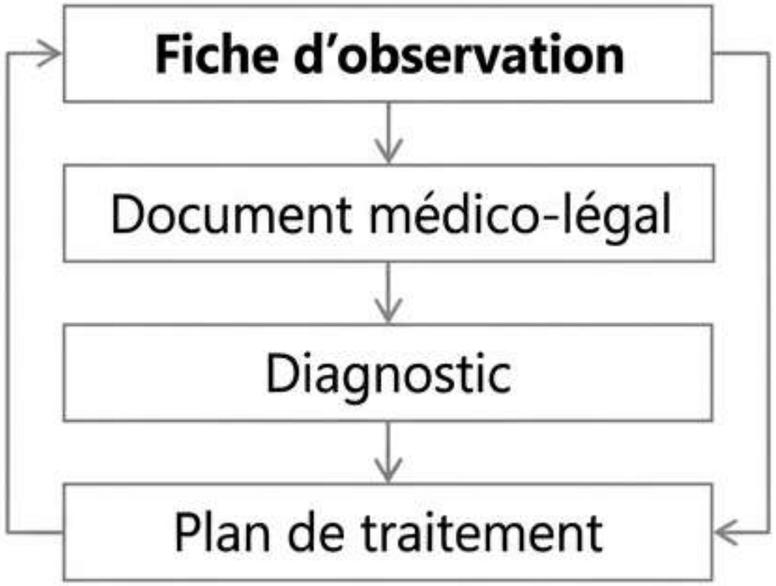
Examens Complémentaires :

- Radiologiques, sanguins, bactériologiques, anatomopathologiques. Objectif : compléter le diagnostic.
- Ils sont complémentaires et NON systématiques. Ne suffisent pas à eux seuls. Rapport coût + risque / bénéfice doit être évalué. [Ref: Q1, Q4, Q5, Q9]

La fiche d'observation :

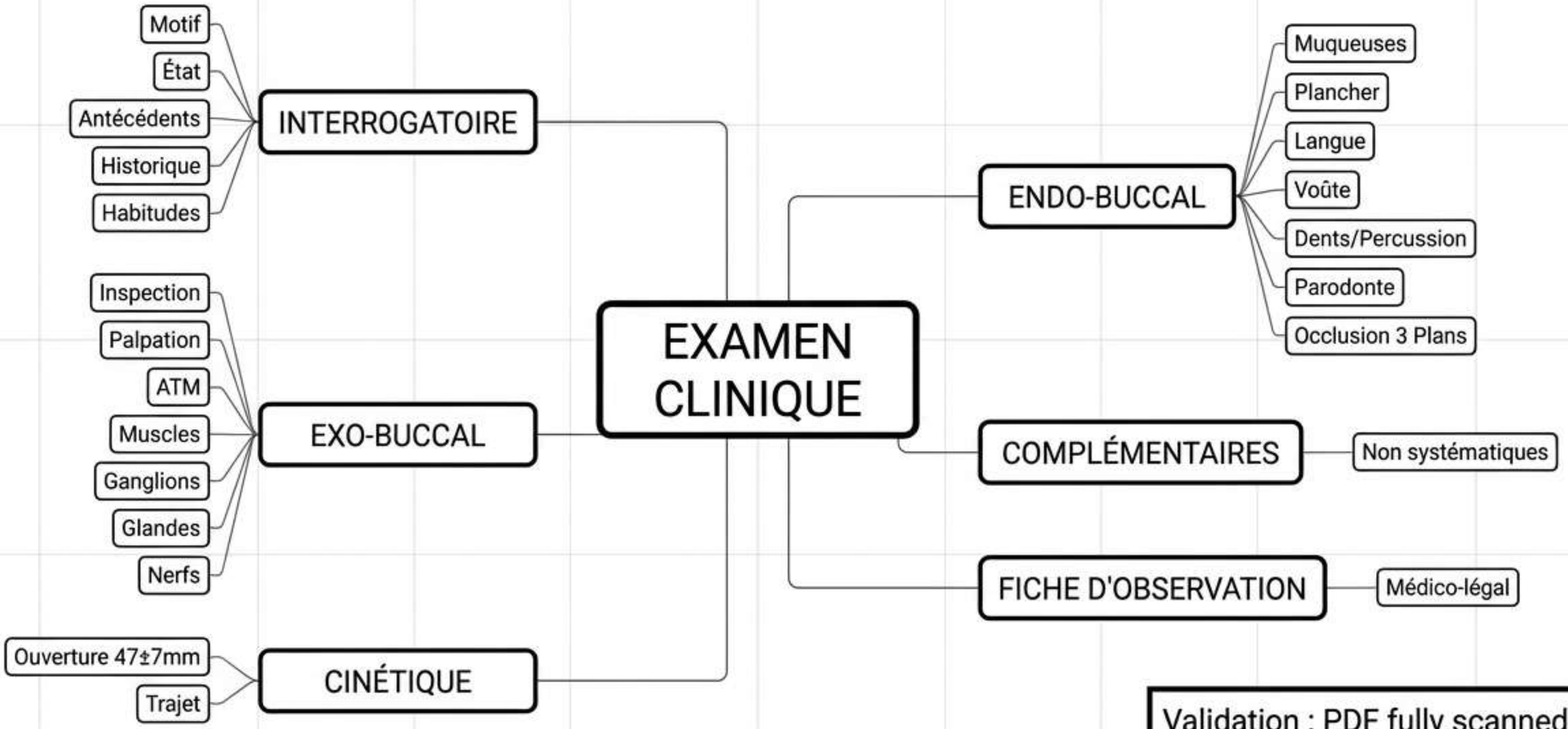
- Rédigée par le praticien (brève, objective, scientifique).
- C'est un document médico-légal, pédagogique et scientifique. [Ref: Q17]





Dentist Web

La Carte Mentale Diagnostique Synthétique



Validation : PDF fully scanned.
100% content coverage confirmed.
No omission detected.

Dentist Web